出　院　记　录

姓名：于文才　性别：男　年龄：69岁　科室：内科综合　床位：13-30　住院号：201909421

姓名：于文才　性别：男　年龄：69岁　入院科室：内科综合　出院科室：内科综合
入院日期：2019-11-18 14:55:53 出院日期：2019-12-04 08:00:00
住院天数：16天
门诊诊断：脑梗塞、高血压
临床初步诊断：腔隙性脑梗塞、脑梗塞后遗症期、高血压病
临床确定诊断：腔隙性脑梗塞、脑梗塞后遗症期、高血压病
入院情况：

患者因“右侧肢体麻木5天，伴肢体无力2天”入院。患者右侧肢体麻木不适感，且伴明显头晕、头沉不适，频繁呛咳，右侧肢体无力感，右手持物不稳，穿衣时右侧肢体活动欠灵，走路右腿拖地且步态不稳，右侧肢体有明显发凉感。查体：体温：36.5℃ 脉搏：70次/分 呼吸：20次/分 血压：130/90mmHg；神经系统检查：意识清楚，言语欠流利，记忆力减退；右上肢肌力4+级，右下肢肌力4+级；右侧指鼻试验欠稳准，右侧跟膝胫试验欠稳准；右侧温度觉减退。辅助检查：头颅CT：腔隙性脑梗塞 可疑脑干低密度影，建议必要时MRI检查 脑萎缩。

治疗经过：

1.给予改善循环、改善脑代谢治疗：0.9%氯化钠注射液250ml+曲克芦丁脑蛋白水解物注射液10ml 日一次静点；0.9%氯化钠注射液100ml+前列地尔10ug 日一次静点。

2.抗血小板聚集、抗动脉硬化、降压药物治疗：阿司匹林肠溶片100mg 日一次口服；阿托伐他汀钙片20mg 日一次口服；替米沙坦片40mg 日一次口服。

3.给予肢体功能治疗：脑血管病针灸 每日一次。

出院情况：

患者病情平稳，无头晕不适，右手持物较前平稳，站立平稳，能短距离行走，步态较前平稳，右侧肢体麻木及无力减轻。**查体：**血压：135/78mmHg。神经系统检查：意识清楚，言语欠流利；右上肢肌力5-级，右下肢肌力5-级；右侧指鼻试验稳、欠准，右侧跟膝胫试验欠准、稳；右侧温度觉减退。

治疗效果（转归）：好转

出院医嘱：

阿司匹林肠溶片100mg 日一次口服；阿托伐他汀钙片20mg 日一次口服；替米沙坦片40mg 日一次口服。低盐低脂饮食，监测血压，适量运动，病情变化随诊。

主治医师（签名）王雪峰　住院医师（签名）王科英/　樊庆欢